



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : وفاء راشد حسن راشد
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : الدرب الأحمر
العنوان : +++
رقم البطاقة : 26003250101489 رقم التليفون : 01101811262
العمر (تاريخ الميلاد) : 25-03-1960 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 07-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /أ.د. /----- /أ.د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: وفاء راشد حسن راشد National ID: 26003250101489	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
مجلس تحقيق الشخصية

وقام
راشد حسن راشد
٢٢ عطية بربره
الدرب الأحمر - القاهرة

٢٦٠٠٣٢٥٠١٠١٤٨٩

١٧٧٢٣٣٥٣

٢٠٢٠/٠٨ ٢٦٠٠٣٢٥٠١٠١٤٨٩
ربة منزل

رشته مسلمة
٢٠٢٧/٠٨/١٧ البطاقة سارية حتى

١



Ministry of Health and Education
Kingdom of Saudi Arabia

الوزارة العامة للصحة والتعليم
المملكة العربية السعودية



A-Patient ID:

1- Name: **ولاء رشيد حسن رشيد**

Sex:

MDT form

3- Medical number:

83354557

Female

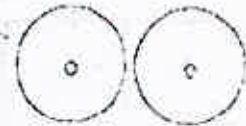
Old Med:

Old Med:

3510-2023

2-ID number: 26003250101499

Patient Age: 64 Y



Family history:

Family history:

Phone:

Phone:

01003362113

BMI:

BMI:

REASON OF MDT:

REASON OF MDT:

Marital status:

Marital status:

RAS score:

RAS score:

GROUP:

GROUP:

Date of MDT:

Date of MDT:

Comorbidity:

Comorbidity:

Menopausal status:

Menopausal status:

Initial STAGE:

Initial STAGE:

22/05/2024

Breast Imaging:		Clinical data			
		Mets Workup:			
DX ILC	ER 8/8	PR 8/8	Her 2 1	SISH	Ag7 25
TYPICAL PAPILARY lesion likely					
T RT T3 LT	N 0 0			M 0	
Sonomammography rt breast OQ non-mass enhancement with related palpable suspicious parenchyma lt breast 12 oclock enhancing asymmetry with related non palpable suspicious parenchyma BIRADS 4					
PATIENT HISTORY RT BCS+AC: EXTENSIVE PLEOMORPHIC LOBULAT CARCINOMA free margins, LN 0/10 IHC 31/1/2024 ILC SISH: NOT AMPLIFIED ER 8/8 PR 0/8 HER2+2 NOTE THAT AT REPORT, IHC ON TRUE CUT BIOBSY FORM R.T BREAST lt WLE: IDC GII with wide DCIS free resection margins RT completion mas tectomy: ILC GII free deep margins infiltration of dermis of nipple, areola free epidermi- BILATERAL BC LT: BCS IDC pT1b for surgical consultation (LT AXILLA) IHC TO LT BREAST					
MDT OUTCOME & PLAN START ADJ cTH AC*3 then Taxotere *3 2-PORT to RT CW + lt BREAST & AXILLA + BOOST 3- RT.					
Will send the pathology report for per breast and 1 in view of metastatic to rt axilla					
MEDICAL ONCOLOGY		SIGNATURE		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY		NUTRITION	
Psychiatric					



Patient Name : الأستاذ / وفاء راشد حسن راشد
Patient No. : 26003250101489
Path No. : 1210/24
Sex : Female
Age : 63 Y
Referring Doc :

Request No. : 13008348
Request Date : 01/04/2024
Verification Date : 21/04/2024
Financial Category : أورام دار السلام - ميكره
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Right & Left breast lesions.

Nature Specimen:

- 1-Right completion mastectomy specimen.
- 2-Left wide local excision.

Gross Examination:

- 1- Procedure: Right completion mastectomy measured 23x17x7 cm with covering skin ellipse measured 21x16 cm.
 - * Tumor extent: Multiple irregular greyish white firm masses.
 - * Size: Ranging in size from 1x1 cm up to 4.5x4 cm.
 - * Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
 - * Distance from margins: 0.2 cm away from deep muscular margin.
- 2- Procedure: Wire-guided Left WLE specimen measured 5x3.5x2.5 cm, with covering skin ellipse measured 2x1 cm.
 - * Tumor extent: A firm grayish white irregular area.
 - Size: 1.2x1 cm
 - * Skin involvement: No.
 - * Distance from margins: 0.4 cm from deep margin.

Microscopic Examination:

- 1- Right:
 - * Histological type: Multifocal Invasive lobular carcinoma.
 - * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II.
 - * In situ component: No LCIS.
 - * Angioinvasion: No.
 - * Perineural invasion: No.

Verified by :
DR. Menna Nabil

Printing Date : 03/05/2025 10:42:55

Page 1 of 3

Printing By : hermal



غرفة رقم (4) - شور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name : الأستاذة / ولاء راشد حسن راشد
Patient No. : 26003250101489
Path No. : 1210/24
Sex : Female
Age : 63 Y
Referring Doc :

Request No. : 13008348
Request Date : 01/04/2024
Verification Date : 21/04/2024
Financial Category : اورام دار السلام - مبادئ
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

- * Microcalcifications: No.
- * Skin involvement: Tumor infiltrates the dermis of nipple & areola with free epidermis.
- * Resection Margins: Free deep margin.

2- Left:

- * Histological Type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II.
- * Ductal carcinoma in situ: Wide DCIS.
- * Skin involvement: No.
- * Angioinvasion: No.
- * Perineural invasion: No.
- * Resection Margins: Free.
- * Microcalcifications: No.

Diagnosis:

1-Right breast cancer, completion mastectomy specimen:

- * Multifocal Invasive lobular carcinoma, grade II.
- * Tumor infiltrates the dermis of nipple & areola with free epidermis.
- * Free deep margin.
- * Stage: pT2(m).

2-Left breast lesion, wide local excision:

- Invasive duct carcinoma, grade II with wide DCIS.
- Free resection Margins.
- Stage: pT1b.

Signature
Prof. Amal Ahmed Hareedy.

Verified by :
DR. Menna Nabil

Printing Date : 03/05/2025 10:42:55

Page 2 of 3

Printing By : hermal



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Name: WAFI RASHED HASSAN
Date : 3 May 2025

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Average in size, smooth outline with homogenous echopattern.. No intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is not dilated and patent.

Gall Bladder: -

- Average in size and in wall thickness. No stones or mud could be seen.
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size, displaying homogenous echopattern.

Kidneys: -

Both are of normal size and site, with normal echogenicity. No sizable stones, focal lesions or backpressure changes could be seen.

- Para-aortic and pancreatic area: no gross lesion
- No ascites could be seen.

URINARY BLADDER: adequate filling with smooth regular outlines, no stones or focal lesions could be seen.

No adnexal masses or cysts could be seen.

Opinion:

Unremarkable study

Best Regards,
Dr. A. Haider, FEBR



Patient Name: Wafaa Rashed Hassan Rashed	Date : 17/03/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 64 Year(s)
Medical ID: 3610/2023	Pat. ID: 38428

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Patient had CBS in right side with recurrence.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B).
- No left breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Right breast UIQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and surgical clips.
- Complementary ultrasound showed right breast UIQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with operative bed seroma measures 4 x 20 mm.
- right retroareolar and UIQ non-palpable altered parenchyma and hypoechoic measures 41 x 23 mm.
- right UOQ subcentimetric anechoic cyst.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel and evidence of recurrent mass lesion pathologically proved ILC (BIRADS 6).

Yours truly

Signature Dr. Wafaa Ali

Patient Name: Wafaa Rashed Hassan Rashed	Date : 03/05/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 65 Year(s)
Medical ID: 3610/2023	Pat. ID: 38428

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Patient is complaining of right MRM

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- left breast ultrasound

Report:

- The left breast :scattered fibro glandular density (ACR B)
- No suspicious mass lesions, suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- Complementary ultrasound showed:
- Status post right MRM showing no optative bed mass lesions or pathological regional LNs.
- Free right supra and infraclavicular regions
- No left breast lesions.
- Normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Single enlarged left axillary LN, with uniform increased cortical thickness reaching 5mm.

Opinion:

- Status post right MRM showing no optative bed mass lesions or pathological regional LNs.
- Left axillary single indeterminate LN for close US follow up BIRDSA3

Yours truly

Signature Dr. basma mohamed

03/05/2025 12:07 PM